

2

乳がん

サブタイプ別に見る薬物療法と副作用対応

1 主な治療レジメン・使用薬剤

細胞障害性抗がん薬

アントラサイクリン系(ドキソルビシン等)+シクロホスファミド、その後タキサン系(パクリタキセル等)

抗HER2療法 (HER2陽性)

トラスツズマブ、ペルツズマブ、T-DXd(抗体薬物複合体)等

内分泌療法 (ホルモン受容体陽性)

タモキシフェン、アロマターゼ阻害薬(レトロゾール等)、CDK4/6阻害薬(パルボシクリブ等)併用

免疫チェックポイント阻害薬

トリプルネガティブ乳癌の一部でペムブロリズマブ等を使用

2 乳がん治療で特に注意すべき副作用



抗HER2療法・アントラサイクリン系の心毒性:治療前後のLVEF評価が必須



CDK4/6阻害薬:骨髄抑制(特に好中球減少)



内分泌療法:更年期様症状、骨密度低下、血栓塞栓症(タモキシフェン)



タキサン系:末梢神経障害

3 サブタイプ別治療選択のポイント

- ☐ ホルモン受容体・HER2発現状況(サブタイプ)により治療方針が大きく異なる
- ☐ HER2陽性例は抗HER2療法が治療の中心となり、心機能フォローが重要
- ☐ ホルモン受容体陽性例は内分泌療法が長期(5~10年)にわたることが多く、アドヒアランス支援が鍵
- ☐ トリプルネガティブ乳癌は化学療法・免疫療法が中心となる

乳がんはサブタイプ(ホルモン受容体・HER2発現)によって治療の全体像が大きく変わる。処方薬から逆算してサブタイプを意識すると、副作用予測がしやすくなる。

がん薬物療法 研修シリーズ — 癌種別ガイド 乳がん — NCCN Guidelines Breast Cancer、CTCAE v5.0に基づく